

GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS EM SAÚDE

Carlos Gustavo Lopes da Silva



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Logística em saúde: farmácia hospitalar

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Definir farmácia hospitalar.
- Descrever as principais funções e processos da farmácia hospitalar.
- Analisar áreas onde podem estar localizadas as farmácias satélites e suas vantagens.

Introdução

Compreender as doenças e o que é saúde sempre foi um grande desafio para a humanidade. Ao estudarmos a teoria da história natural da doença, compreendemos que a interação do indivíduo com o ambiente e os agentes externos resulta em processos de saúde ou de doença, e essa é uma característica inerente a todos os seres humanos, desde os primórdios da civilização. Com a mudança de paradigma sobre a origem das doenças e do conceito de saúde, da Idade Média até os dias atuais, inúmeras teorias ganharam destaque e tantas outras foram refutadas à luz da ciência.

Dentro desse contexto nascem os hospitais, espaços onde os doentes são tratados para que possam retornar a sua vida normal na sociedade. No século XXI vemos nascer um novo hospital, ligado às novas tecnologias, mas que mantém no seu âmago a meta de prestar cuidados e atenção ao paciente, por meio de diagnósticos, tratamentos e internações. Além disso, os medicamentos, os fármacos em geral, são importantes para o restabelecimento do equilíbrio na saúde, em conjunto com outros procedimentos médicos. Diante dessa necessidade, estabelece-se a farmácia hospitalar como um elemento crucial, inserida na rotina hospitalar, em busca da qualidade dos serviços prestados à comunidade.

Neste capítulo, você vai estudar a farmácia hospitalar, seu conceito e principais funções, processos e atividades dentro do âmbito hospitalar. Além disso, verá como ocorre a implementação das farmácias satélites e suas vantagens na dinâmica de atenção à saúde.

1 Conceito

Atualmente, os hospitais têm um novo papel na sociedade, que vai muito além de ser um mero local que os indivíduos procuram quando se sentem doentes ou buscam procedimentos médicos como cirurgias e partos. Os hospitais de hoje são centros de referência para a formação de futuros profissionais de saúde, bem como para a obtenção, por meio da pesquisa, de novos conhecimentos sobre doenças, tratamentos e diagnósticos.

Segundo Cavallini e Bisson (2010), as novas características dos hospitais no século XXI são as seguintes:

- **Assistência:** respeito aos princípios éticos da condição humana, utilizando tecnologias apropriadas a cada situação, tendo o cuidado de considerar a tecnologia como um meio e não um fim, isto é, sendo um apoio aos profissionais de saúde.
- **Pesquisa:** geração de novos conhecimentos, buscando a excelência em qualidade e credibilidade no atendimento ao paciente e/ou usuário.
- **Educação:** formação continuada dos profissionais de saúde, mantendo constantes atualizações e estímulo ao desenvolvimento de novas competências.
- **Informação atualizada:** uso das tecnologias da informação para dinamizar e facilitar a comunicação entre as equipes e pacientes, além do contato com conhecimentos de outros centros médicos.
- **Aproximação:** atividades de promoção da saúde para aproximação das comunidades.
- **Estimulação:** estimular medidas de prevenção de doenças, dentro do campo da prevenção primária.

Nesse novo contexto do hospital, frente às mudanças sociais, culturais e políticas do século XXI, chegamos ao papel e função da **farmácia hospitalar** como um importante setor dentro dos serviços hospitalares, contribuindo de forma dinâmica e integral na atenção e cuidados aos pacientes.

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), por meio da Resolução nº. 300, de 30 de janeiro de 1997, regulamenta e conceitua o que vem a ser a farmácia hospitalar: uma unidade clínica, administrativa e econômica, dirigida por um farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao paciente (BRASIL, 1997).



Saiba mais

A noção de farmácia hospitalar existe desde a época dos antigos gregos, romanos e árabes. Na Idade Média, a medicina e a farmácia se desenvolviam paralelamente, sem terem uma separação de funções, estando sob a responsabilidade de religiosos de conventos, boticas e hortas de plantas medicinais.

No Brasil colônia havia as boticas, onde os medicamentos eram preparados e comercializados. No século XIX as boticas passaram a fornecer insumos e medicamentos a hospitais da época. Somente na década de 1940, com o crescimento dos hospitais, é que as farmácias hospitalares passaram a ter grande relevância no cenário da saúde, tornando-se crucial para o funcionamento da estrutura organizacional hospitalar (SIMONETTI; NOVAES; AFONSO, 2009).

A farmácia hospitalar tem a responsabilidade de avaliar os resultados da assistência prestada ao paciente, indo além de prover produtos e serviços. Seu papel é essencial na organização dos processos no hospital, pois é uma unidade clínica que deve contribuir com a atenção ao paciente e suas necessidades tendo o medicamento como instrumento de intervenção.

Segundo Cavallini e Bisson (2010), nas atividades de assistência, temos as seguintes ações, que são de competência da farmácia hospitalar:

- Coordenação técnica na seleção e aquisição de medicamentos, germicidas e correlatos, sempre garantindo a qualidade e eficácia da terapia medicamentosa.
- Cumprimento das normas e regulamentos sobre armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos e correlatos, bem como materiais médico-hospitalares.

- Estabelecimento de um sistema eficiente e seguro de dispensação de medicamentos para pacientes ambulatoriais e internados, bem como fornecimento de materiais médico-hospitalares para os profissionais de saúde do hospital.
- Disponibilização de um setor de farmacotécnica para manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; manipulação e controle de antineoplásicos; preparação e diluição de germicidas; reconstituição de medicamentos, preparação de misturas intravenosas e de nutrição parenteral; fracionamento de doses; produção de medicamentos e outras atividades de acordo com as características e realidade de cada hospital.
- Elaboração de manuais, protocolos e formulários exclusivos.
- Manutenção de um membro permanente nas comissões de farmácia e terapêutica, padronização de medicamentos, licitação, parecer técnico e suporte nutricional.
- Atuação na central de esterilização, orientando sobre processos de desinfecção e esterilização de materiais.
- Participação em estudos de ensaios clínicos e programa de farmacovigilância do hospital.
- Atividade de formação continuada, promovendo cursos e palestras, bem como a criação de um setor de informações de medicamentos de acordo com a realidade de cada hospital.
- Implementação da farmácia clínica.
- Atividades de pesquisa, desenvolvimento e tecnologias farmacêuticas, no preparo de medicamentos e germicidas.

O **farmacêutico responsável técnico** (diretor do setor) deve cumprir e fazer cumprir a legislação ligada às atividades hospitalares e à assistência/atenção farmacêutica. Ainda deve organizar, supervisionar e orientar tecnicamente todos os setores que fazem parte da farmácia hospitalar, contribuindo para o funcionamento em harmonia com o conjunto da unidade hospitalar.

O cotidiano da farmácia hospitalar requer a aplicação de um mosaico de conhecimentos administrativos, desde os básicos e fundamentais, envolvendo teorias administrativas, planejamento, controle, administração de recursos humanos, até o desenvolvimento e gerenciamento de projetos (CAVALLINI; BISSON, 2010).

2 Funções e estrutura

O Conselho Federal de Farmácia (CFF), por meio da Resolução nº. 300/1997, define como principal função da farmácia hospitalar garantir a qualidade de assistência prestada ao paciente por meio do uso racional de medicamentos e correlatos, adequando sua utilização à saúde individual e coletiva, envolvendo os planos assistencial, preventivo, docente e de investigação, contando com farmacêuticos em número suficiente para o bom desempenho da assistência farmacêutica (BRASIL, 1997).

A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (2017) reconhece sete atribuições essenciais da farmácia hospitalar, que devem ser seguidas e implementadas na sua estrutura de funcionamento e atividades. São elas:

- **Gestão:** deve focar na prestação da assistência farmacêutica. Tem uma estrutura organizacional com missão, valores e visão de futuro, estando a farmácia hospitalar inserida no organograma institucional. Ainda precisa formular, implementar e acompanhar os planos estratégicos, estabelecendo indicadores para avaliações regulares e constantes. Outra função é acompanhar o desempenho financeiro e orçamentário. Deve ainda participar das comissões de formulação de políticas e procedimentos relacionados à assistência farmacêutica, englobando Comissão de Farmácia e Terapêutica, Comissão de Controle da Infecção Hospitalar, Comissão de Ética, Comissão de Suporte Nutricional, Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Saúde, Comissão de Avaliação de Tecnologias, Comissão de Riscos Hospitalares e outras.
- **Desenvolvimento de infraestrutura:** garantir a base material para atuação efetiva do farmacêutico na farmácia hospitalar, incluindo a disponibilidade de equipamentos e de instalações adequadas ao gerenciamento (logística de suprimento) de medicamentos, saneantes e produtos estéreis e não estéreis. Ainda deve fazer a implantação de um sistema informatizado, com disponibilidade de recursos para informação e comunicação (computadores, impressoras, *softwares*, *hardwares* e outros), e estabelecer salas para práticas de atividades farmacêuticas: áreas para segregação de produtos vencidos, avariados e em quarentena, área para produtos e medicamentos com controle especial, com trancas. Os móveis devem ser ergonomicamente compatíveis a cada atividade exercida na farmácia hospitalar, sem porosidades, ranhuras ou fendas, com superfícies resistentes à ação de saneantes.

- **Logística farmacêutica e preparo de medicamentos:** implantar um sistema racional de armazenamento, distribuição e dispensação, visando à segurança do paciente. As prescrições médicas precisam ser analisadas pelo farmacêutico antes da dispensação dos medicamentos, tendo cuidado com o nome do medicamento, dose, modo de preparo e utilização, via de administração, posologia, incompatibilidades e interações medicamentosas. Todo o processo tem que ser devidamente registrado com apoio dos sistemas de informação, para que possa haver um controle e rastreabilidade de todas as etapas dos processos.
- **Otimização da terapia medicamentosa:** aumentar a efetividade da intervenção terapêutica, promovendo o uso racional e garantindo a qualidade da farmacoterapia, devendo ser realizado com apoio da diretoria clínica e a colaboração da comissão de farmácia terapêutica. O uso racional de medicamentos consiste em obter o efeito terapêutico adequado à situação clínica do paciente, utilizando o menor número de fármacos, no período mais curto e com o menor custo possível. Cabe ao farmacêutico selecionar os pacientes que têm necessidade de monitoramento, devido à baixa adesão ao tratamento, ao uso de medicamentos potencialmente perigosos, com maior potencial de causar efeitos adversos e de alto custo, além de ao uso por crianças e idosos. Avaliar continuamente a resposta terapêutica.
- **Farmacovigilância e segurança do paciente:** a farmacovigilância, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), consiste na ciência e nas atividades relacionadas à detecção, avaliação, compreensão, prevenção de efeitos adversos ou quaisquer outros possíveis problemas relacionados a medicamentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, 2017). Sendo assim é responsabilidade da farmácia hospitalar implantar a farmacovigilância, para minimizar os riscos da farmacoterapia envolvendo o surgimento de reação adversa a medicamento (RAM); avaliar os eventos adversos relacionados a medicamentos, medicamentos de baixa qualidade, erros de medicação; notificar em caso de intoxicação aguda ou crônica; avaliar a mortalidade relacionada a medicação, abuso e uso indevido dos medicamentos e interações medicamentosas adversas com substância

química, outros medicamentos e alimentos. A farmácia hospitalar é responsável pela implantação do Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, disponibilizado pelo Ministério da Saúde como parte integrante do Programa Nacional de Segurança do Paciente, tendo por objetivo promover práticas seguras no uso de medicamentos.

- **Informações sobre medicamentos e produtos para saúde:** a farmácia tem a responsabilidade de fornecer à equipe de saúde e pacientes informações técnico-científicas sobre eficácia, segurança, qualidade e custos dos medicamentos e produtos para a saúde. Com a finalidade de elaborar informações seguras e atualizadas, a farmácia hospitalar deve ter a sua disposição fontes de informações primárias, secundárias, terciárias, isentas e atualizadas, baseadas em evidências científicas. Ainda a farmácia deve elaborar guias e boletins informativos sobre o uso de medicamentos.
- **Ensino, educação permanente e pesquisa:** a farmácia hospitalar deve promover, participar e apoiar ações de educação permanente, ensino e pesquisa nas suas atividades administrativas, técnicas e clínicas, com participação de farmacêuticos e demais profissionais e estudantes. A formação, capacitação e qualificação dos recursos humanos precisam ser contínuas. Ainda a farmácia pode promover, participar e apoiar pesquisas inseridas em seu âmbito de atuação, com o objetivo de produzir informações que auxiliem no aprimoramento das práticas e promover o uso racional de medicamentos e demais produtos para a saúde, contribuindo com a melhoria da qualidade da assistência farmacêutica. As atividades de ensino, educação permanente e pesquisa devem priorizar atender às necessidades dos usuários e da população em geral.

Por meio dessas atribuições essenciais, a farmácia hospitalar se constitui uma unidade de suma importância na estrutura organizacional do hospital. Seus princípios são garantir o uso seguro e racional das medicações prescritas pelo profissional médico e, ao mesmo tempo, responder à demanda e necessidade de medicamentos dos pacientes hospitalizados (SIMONETTI; NOVAES; AFONSO, 2009).



Saiba mais

Em 2004, a OMS, preocupada com os danos sofridos pelos pacientes, criou o programa Patient Safety Program (Programa de Segurança ao Paciente) para organizar os conceitos e as definições sobre segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos e os eventos adversos. Assim, a International Classification for Patient Safety (ICPS, ou Classificação Internacional de Segurança do Paciente) definiu os conceitos-chave em segurança do paciente, que você pode conferir a seguir:

- **Segurança do paciente:** reduzir a um mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- **Dano:** comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou psicológico.
- **Risco:** probabilidade de um incidente ocorrer.
- **Incidente:** evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário ao paciente.
- **Circunstância notificável:** incidente com potencial dano ou lesão.
- **Near miss ou quase falha:** incidente que não atingiu o paciente.
- **Incidente sem lesão:** incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano.
- **Evento adverso:** incidente que resulta em dano ao paciente.

Fonte: Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (2017).

Estrutura organizacional: ambientes, equipamentos e recursos humanos

A farmácia hospitalar, com seus serviços de saúde, é considerada uma unidade clínica e administrativa do hospital. Por isso ela precisa ser contemplada no organograma e ter gestão autônoma e independente, preservando o interesse da instituição (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, 2017).

Dentro da estrutura do hospital, a farmácia hospitalar deve estar localizada em uma área que facilite o acesso dos pacientes e das unidades hospitalares e precisa ter recursos de comunicação e transporte eficientes. Ela ainda precisa ter os seguintes ambientes para o pleno funcionamento da farmácia: áreas para administração, armazenamento, dispensação e atendimento farmacêutico.

Caso a farmácia, dentro da realidade de cada hospital, necessite de outras atividades, como manipulação magistral e oficial, manipulação de desinfetantes, fracionamento, produção de *kits*, manipulação de antineoplásicos, nutrição parenteral e outras misturas intravenosas, manipulação de radiofármacos e outras, ela precisará de ambientes mais específicos para cada atividade, seguindo a legislação vigente.

A gerência da farmácia deve ter um ambiente privativo, com suporte administrativo e recursos para atividades de informação e comunicação dos serviços de saúde prestados ao hospital. Deve ainda haver um ambiente para farmacovigilância e, caso haja dispensação ambulatorial de medicamentos, uma área para a organização de um consultório farmacêutico (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, 2017).

Veja no Quadro 1, a seguir, os parâmetros mínimos para os ambientes da farmácia hospitalar segundo a SBRAFH.

Quadro 1. Parâmetros mínimos para ambientes da farmácia hospitalar

Área	Parâmetro mínimo para ambiente
Recepção e inspeção	Devem ter lâmpadas de segurança.
Central de abastecimento farmacêutico	Imunobiológicos: <i>freezer</i> ou geladeira. Termolábeis: geladeira. Deve ter lâmpadas de segurança, tomadas ligadas ao gerador em número igual ao dos <i>freezers</i> e geladeiras.
Área de distribuição	Condizente com a área de armazenagem. Deve ter lâmpadas de segurança, tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras.
Sala de chefia	Deve ter lâmpadas de segurança.
Área administrativa	Deve ter lâmpadas de segurança.
Sala de reuniões	Deve ter lâmpadas de segurança.
Farmácia satélite	Deve ter lâmpadas de segurança, tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Parâmetros mínimos para ambientes da farmácia hospitalar

Área	Parâmetro mínimo para ambiente
Central de misturas intravenosas — CMIV (manipulação de NPT ou citotóxicos ou outras misturas intravenosas)	Deve ter, no mínimo, os seguintes ambientes: ■ Sala de manipulação, sala de limpeza e higienização dos produtos e antecâmara (vestiário de barreira). A sala de manipulação deverá ter no mínimo 5m². ■ Capela de fluxo laminar ou cabine de segurança biológica, desde que assegurada a limpeza, a manutenção e as operações segundo as boas práticas. Deve ter: ■ lâmpadas de segurança; ■ exaustão; ■ proteção contra entrada de aves, animais, insetos, roedores e poeiras; ■ superfícies internas lisas, sem rachaduras, resistentes aos saneantes, que não desprendam partículas e facilmente laváveis; ■ ralos sifonados e fechados; ■ tetos rebaixados devem ser selados para evitar contaminação proveniente de espaço acima deles; ■ lavatórios devem ter torneiras ou comandos que dispensem o contato das mãos para o fechamento da água; ■ sala exclusiva para preparação de medicamentos para terapia citotóxica dotada de cabine de segurança biológica, Classe IIB2; ■ tubulações embutidas nas paredes, vedada a existência de ralos; ■ entrada na área de manipulação com antecâmara (vestiário de barreira); ■ vestiários fechados com dois ambientes para mudança de roupa; ■ portas das câmaras com sistema de travas e alerta visual para evitar abertura simultânea; ■ instalação de água potável com materiais impermeáveis; ■ cantos de paredes arredondados.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Parâmetros mínimos para ambientes da farmácia hospitalar

Área	Parâmetro mínimo para ambiente
Farmacotécnica (manipulação magistral e oficial)	Lavagem de utensílios e materiais; manipulação de sólidos, semissólidos e líquidos; controle de qualidade. Deve ter: ■ lâmpadas de segurança; exaustão; ■ destilador ou osmose reversa; ■ tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras; ■ superfícies internas lisas, sem rachaduras, resistentes aos saneantes, que não desprendam partículas e facilmente laváveis; ■ ralos sifonados e fechados; ■ tetos rebaixados devem ser selados para evitar contaminação proveniente de espaço acima deles; ■ esgoto químico.
Sala de diluição de germidas	Deve ter destilador ou osmose reversa, lâmpadas de segurança, exaustão e esgoto químico.
Sanitários e vestiários	1 para cada sexo, 1 bacia sanitária e 1 lavatório para cada 10 funcionários. Devem ter lâmpadas de segurança.
Depósito de material de limpeza (DML)	1 unidade
Copa	1 unidade
Farmácia ambulatorial (gerenciamento, dispensação e controle de estoque)	Devem ter lâmpadas de emergência e tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras.
Orientação farmacêutica (paciente ambulatorial)	Consultório de atendimento. Deve ter lâmpadas de emergência.
Fracionamento ou unitarização	Devem ter lâmpadas de emergência e tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras.
Produção de kits	Deve ter lâmpadas de emergência.

(Continua)

(Continuação)

Quadro 1. Parâmetros mínimos para ambientes da farmácia hospitalar

Área	Parâmetro mínimo para ambiente
Farmácia em centro cirúrgico	20 m ² . Deve ter lâmpadas de emergência e tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras.
Farmacovigilância	Deve ter lâmpadas de emergência.
Informação sobre medicamentos	Deve ter lâmpadas de emergência.
Farmacocinética clínica	20 m ² . Deve ter lâmpadas de emergência; tomadas ligadas ao gerador em número igual ao de <i>freezers</i> e geladeiras; exaustor; esgoto químico.
Pesquisa clínica (consultório de atendimento e dispensação de medicamentos em ensaios clínicos)	Consultório de atendimento. Deve ter lâmpadas de emergência.
Sala de aula	Deve ter lâmpadas de emergência.

Fonte: Adaptado de Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (2017).

Outros pontos importantes na organização da estrutura da farmácia hospitalar é que os sanitários não devem ter comunicação direta com as áreas de manipulação e armazenamento, as salas de descanso e refeitório devem ser separadas dos demais ambientes e todos os ambientes precisam seguir as normas vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para ambientes da farmácia hospitalar.

Com relação aos equipamentos de proteção coletiva e individual (EPC e EPI), eles devem seguir o estabelecido nas normas trabalhistas, em especial no Programa de Prevenção e Risco de Acidentes (PPRA) e no Programa Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Ainda é necessário que todos equipamentos e utensílios sigam as normas do INMETRO, evidenciando a aferição, calibração e certificações (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, 2017).

Como parâmetros mínimos para equipamentos e utensílios temos os seguintes:

- **Equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva:** cabines de segurança biológica, fluxo laminar, máscaras, gorros, aventais, capotes, óculos de proteção e luvas.
- **Medição:** termômetros de transporte, termômetro de refrigeradores e de ambientes, termo-higrômetros, balanças e pHmetros.
- **Conforto ambiental:** condicionadores de ar com manutenção preventiva e corretiva, mantendo a temperatura ambiente abaixo dos 25°C.
- **Guarda e acondicionamento de produtos:** refrigeradores, *freezers*, câmaras de vacina e câmaras frias, *pallets*, estantes, armários, caixas térmicas, caixas plásticas, *bins*, gelo de transporte, caixa plástica com tranca para guarda de produtos sujeitos a controle especial (UTIs, pronto atendimento e bloco cirúrgico) e bandejas.
- **Unitarização, fracionamento e montagem de kits:** seladora plástica, encapsuladoras e envasadoras.
- **Informática:** computadores, leitores de código uni e bidimensionais, impressoras e rotuladoras.
- **Transporte:** carrinho tipo bandeja e carinho tipo plataforma.
- **Outros utensílios e insumos:** vidrarias, bandejas, bobinas plásticas, etiquetas, fitas e outros necessários ao serviço.

Com relação aos recursos humanos, a unidade de farmácia hospitalar deve ter farmacêuticos e auxiliares em número adequado com as atividades realizadas, mantendo todos os processos com segurança, sem sobrecarga ocupacional, respeitando o limite de carga-horária semanal conforme a legislação trabalhista vigente. É necessária a presença de um farmacêutico como técnico responsável durante todo o horário de funcionamento da farmácia.



Fique atento

A quantidade de farmacêuticos e de auxiliares vai depender das atividades desenvolvidas, da complexidade dos cuidados, do número de leitos no hospital e do nível de informatização e mecanização da unidade. Ela deve preconizar o bom funcionamento dos serviços prestados, priorizando a segurança do paciente, a qualidade na assistência, a efetividade na terapia medicamentosa, o uso racional de medicamentos, o controle de infecção e o cumprimento da legislação sanitária vigente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE, 2017).

3 Farmácias satélites

Dentro do hospital existem diversos setores, com características específicas e necessidades próprias com relação à dispensação de materiais e medicamentos. Como exemplo temos o centro cirúrgico (CC), a unidade de terapia intensiva (UTI), o ambulatório e o pronto-socorro. Em cada um desses setores, existe a necessidade de receber materiais e medicamentos diferenciados, pois existem aspectos diferentes, como os listados a seguir:

- estoques elevados de materiais e medicamentos sem controle efetivo, como os fios cirúrgicos no CC, sondas, seringas e agulhas na UTI;
- consumo excessivo de medicamentos;
- custo unitário do que é consumido alto;
- uso inadequado de itens, levando ao desperdício;
- itens que necessitam de cuidados especiais no armazenamento e controle.

Por conta dessas características setoriais existe uma necessidade de assistência farmacêutica efetiva em locais focais, surgindo assim a necessidade de implementação de farmácias satélites. Uma farmácia satélite é uma farmácia localizada no próprio setor da dispensação, com a finalidade de estocar os materiais e medicamentos específicos do setor, proporcionando uma assistência farmacêutica efetiva e direta (CAVALLINI; BISSON, 2010).

Passos para a implantação de uma farmácia satélite

Para compreendermos como ocorre a implantação de uma farmácia satélite dentro de um hospital, vamos focar no centro cirúrgico. Trata-se de um local os pacientes permanecem apenas o tempo necessário para a intervenção cirúrgica, sendo localizado em área isolada no hospital para facilitar o fluxo de profissionais de saúde que vão realizar técnicas cirúrgicas e medidas assépticas necessárias nesse ambiente.

Na implantação de uma farmácia satélite no centro cirúrgico, é necessário, em primeiro lugar, conhecer as características principais do local: número de salas no centro cirúrgico; número de cirurgias por mês; número de salas no centro obstétrico; número de partos ao mês; número de leitos na sala de recuperação. Em especial, é preciso analisar a planta física e os fluxos de circulação do setor com uma equipe multidisciplinar, envolvendo enfermeiros, médicos, engenheiros, etc. (CAVALLINI; BISSON, 2010).

Outro ponto importante é conhecer os detalhes da demanda do centro cirúrgico, verificando como se comporta seu estoque (agulhas, fios, soros, anestésicos e outros); se ocorre consumo excessivo de materiais; quais são os custos e o consumo de órteses, próteses e materiais especiais (como válvulas, cateteres, *clips* de aneurisma e outros); como é o armazenamento dos materiais e medicamentos; e qual a necessidade de uma assistência farmacêutica efetiva.

Antes de efetuar a implantação da farmácia satélite no centro cirúrgico é necessário definir os pontos de atuação, atividades e estrutura organizacional, focando nos seguintes pontos:

- o farmacêutico deve visitar o setor, conhecer e vivenciar a rotina, para ter embasamento na escrita do projeto e adequação do espaço físico;
- o local de escolha para implantação da farmácia satélite tem que ser de fácil acesso a toda a equipe, tanto do centro cirúrgico quanto do centro obstétrico;
- o tipo de sistema de dispensação, como os *kits* cirúrgicos, deve ser definido.
- capacitação dos profissionais que vão atuar na farmácia satélite.

Após essa análise inicial, deve-se elaborar os *kits* com o apoio das equipes médicas, procurando seguir uma padronização semelhante à dos medicamentos. Todos os profissionais envolvidos no centro cirúrgico precisam analisar os *kits* para se certificarem de que tudo está inserido para a necessidade específica do *kit*, como, por exemplo, *kit* postectomia (cirurgia infantil), *kit* laparotomia exploradora (cirurgia geral), *kit* fêmur (ortopedia), *kit* parto normal (ginecologia e obstetria), *kit* cesariana (ginecologia e obstetria), entre outros.



Fique atento

Os *kits* devem ser confeccionados com muita atenção, e devem ser adaptados à realidade dos procedimentos executados naquele centro cirúrgico, daquele hospital.

Ainda dentro dos passos para implantação da farmácia satélite, indica-se a elaboração de um mapa cirúrgico (ficha em formato de tabela), que deve conter os dados mais importantes para a montagem dos *kits* pela equipe da farmácia. Esse mapa precisa conter o horário da cirurgia, o nome do paciente, o número da sala cirúrgica, o nome da clínica, o nome do *kit*, o espaço para ser anotado a rubrica de retirada e devolução do *kit*.

Outro ponto importante se refere ao faturamento dos gastos da conta do paciente, que deve ser informatizado e realizado diretamente na unidade satélite. A farmácia satélite deve ter um sistema informatizado e computador no local, que se comunique com a farmácia hospitalar principal do hospital.

Após a implantação da farmácia satélite, teremos uma rotina na seguinte sequência:

1. O mapa cirúrgico é encaminhado à farmácia satélite um dia antes da cirurgia eletiva.
2. Os funcionários da farmácia manipulam os *kits* de cada cirurgia por clínica, identificando o nome do paciente e o horário da cirurgia (geralmente os *kits* são acondicionados em bandejas plásticas e lacrados com plástico).
3. Os *kits* de anestesiologia podem ser previamente preparados, pois são encaminhados em todas as cirurgias, de acordo com o tipo de anestesia (geral, raquidiana, peridural).
4. O *kit* psicotrópico pode seguir a rotina de anestesiologia, mas deve-se encaminhar o receituário em branco para o médico preencher após a cirurgia.
5. No dia cirurgia, a circulante da sala cirúrgica retira os *kits* (específico do paciente, anestesiologista e psicotrópico), registra a taxa (gastos financeiros do paciente) na folha de sala e reúne os medicamentos e materiais que serão utilizados pelo paciente, assinando no mapa cirúrgico.
6. Após o término da cirurgia, a circulante devolve os *kits* utilizados junto com as anotações na folha de sala e assina a devolução no mapa cirúrgico.
7. O funcionário da farmácia confere os *kits* utilizados e as anotações feitas na folha de sala, a fim de encaminhar a cobrança informatizada. O que for utilizado em cirurgia deverá ser cobrado na taxa (gastos do paciente) e retirado do estoque.
8. O faturamento é feito com base na taxa (gastos do paciente), que é conferida após a devolução dos *kits*.

Após todo esse processo, pode-se verificar muitos resultados positivos na implantação de uma farmácia satélite dentro do centro cirúrgico, como racionalização do estoque de materiais e medicamentos; redução do desperdício de materiais e medicamentos; salas cirúrgicas sem estoques; melhoria no faturamento; redução de contaminação cruzada entre salas cirúrgicas; interação entre equipes multiprofissionais; efetiva assistência farmacêutica e controle a produtividade por meio dos relatórios (CAVALLINI; BISSON, 2010).

Neste capítulo você estudou o conceito de farmácia hospitalar e sua importância para o funcionamento do hospital, vendo que se trata de uma unidade de grande relevância. Viu também como se organiza a estrutura da farmácia hospitalar e como se implantam as farmácias satélites.



Referências

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. *Resolução nº 300, de 30 de janeiro de 1997*. Regulamenta o exercício profissional em Farmácia e unidade hospitalar, clínicas e casas de saúde de natureza pública e privada. Brasília, DF, 1997. Disponível em: <http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/300.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020.

CAVALLINI, M. E.; BISSON, M. P. *Farmácia hospitalar: enfoque em sistema de saúde*. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2010.

SIMONETTI, V. M. M.; NOVAES, M. I. O.; AFONSO, M. W. Gestão de suprimentos da farmácia hospitalar com a implantação de métodos gerenciais de insumos utilizados na manufatura. *Revista Eletrônica Produção Engenharia*, v. 2, n. 1, p. 57–68, 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/producaoengineharia/article/view/28945>. Acesso em: 25 abr. 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FARMÁCIA HOSPITALAR E SERVIÇOS DE SAÚDE. *Padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde*. 3. ed. São Paulo: SBRAFh, 2017. Disponível em: <http://www.sbrafh.org.br/site/public/docs/padroes.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020.

Leitura recomendada

JACOBS, F. R.; CHASE, R. B. *Administração de operações e da cadeia de suprimentos*. Porto Alegre: AMGH, 2012.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS